

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

INFORMATIVA AL PAZIENTE RETTOSIGMOIDOSCOPIA

Informativa e consenso per l'esecuzione
della rettosigmoidoscopia

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-INF037_00	00	27/04/2026	3
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI	Direzione Generale	Interno	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Rosetta Greco	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
27/04/2026	27/04/2026	27/04/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

Che cos'è la rettosigmoidoscopia

La rettosigmoidoscopia è un esame diagnostico che consente al medico di vedere all'interno dell'ultimo tratto dell'intestino (circa 30 cm dall'ano) e di individuare la presenza di malattie infiammatorie intestinali o altre patologie. L'indagine viene effettuata dal medico specialista coadiuvato da personale infermieristico specializzato. È possibile eseguire l'esame in sedazione.

Esecuzione

L'indagine è eseguita con l'ausilio del colonscopio, strumento flessibile del diametro di circa 1 cm dotato di telecamera. Sarà chiesto di distendersi sul lettino posizionandosi sul fianco sinistro. L'esame dura da 20 a 40 minuti. Durante l'esame può essere necessario prelevare un campione di tessuto sospetto per le indagini di laboratorio. Il prelievo non provoca dolore.

Complicanze

La rettosigmoidoscopia è una pratica molto sicura. Le complicanze clinicamente significative sono rare (inferiori allo 0,5%) e comprendono: complicanze cardio-respiratorie (estremamente rare), infezioni (circa il 4% transitorio passaggio di batteri), emorragia (molto rara, autolimitante), perforazione (0,01-0,08% diagnostica, 0,1% operativa).

Preparazione

Tre giorni prima dell'esame **NON MANGIARE**: alimenti integrali, frutta, verdura, legumi ed alimenti contenenti semi. Assumere tanta acqua per mantenere pulito il tratto interessato.

Esame al mattino (ore 8-12)

Quando	Istruzione
Giorno precedente - Sera	Cena leggera; clistere evacuativo (100 ml) alle ore 21, trattenere almeno 15 min
Giorno precedente - Mezzanotte	Digiuno; solo acqua, camomilla, the fino a 3 ore prima dell'esame
Giorno esame - 2 ore prima	Clistere da 100 ml (Clisma-fleet), trattenere almeno 15 min
Giorno esame	Digiuno da solidi; liquidi chiari fino a 3 ore prima

Esame al pomeriggio (ore 12:30-18)

Quando	Istruzione
Giorno precedente	Cena leggera
Giorno esame - Colazione	The, caffè e 1-2 fette biscottate, poi digiuno da solidi
Giorno esame - 4 ore prima	Clistere da 100 ml (Clisma-fleet), trattenere almeno 15 min
Giorno esame - 2 ore prima	Clistere da 100 ml (Clisma-fleet), trattenere almeno 15 min

Pazienti in terapia anticoagulante/antiaggregante

In caso di assunzione di farmaci anticoagulanti o antiaggreganti (Coumadin, Cardioaspirina, Aspirina, Ticlopidina, Clopidogrel, Plavix, Xarelto, Eliquis, Dabigatran, Apixaban, Pradaxa, Lixiana,

ecc.), è necessario contattare il proprio medico curante per valutare la sospensione o sostituzione della terapia.

Sedazione

Per limitare il disagio è possibile eseguire la sedazione (cosciente o profonda), gestita dal medico anestesista. La sedazione deve essere richiesta in sede di prenotazione. Se sedati, è indispensabile presentarsi accompagnati. Guida controindicata per 24 ore.

Prescrizioni, esami precedenti e terapie

Per l'esecuzione è necessaria la richiesta medica con espresso il quesito diagnostico. Portare precedenti indagini strumentali e di laboratorio. Segnalare terapie in atto. Nota: l'esame non può essere eseguito insieme a RX "Apparato Digerente" (intervallo minimo 2 giorni).